DOI:10.16344/j.cnki.10-1669/r4.2024.18.012

·论著·

针刺联合穴位推拿对孤独症言语障碍患儿言语功能及行为症状的影响

李重才

（郯城县妇幼保健计划生育服务中心儿童康复科，山东临沂　276100）

摘要：目的　探究针刺联合穴位推拿对孤独症言语障碍患儿言语功能及行为症状的影响。**方法**　选取 2022 年 10月—2023 年 5 月本院收治的 50 例孤独症言语障碍患儿为研究对象，按照随机数字表法将其分为对照组和观察组，各 25例。对照组采用常规训练，在此基础上，观察组采用针刺联合穴位推拿。比较两组的临床疗效、言语功能及行为症状。**结果**　观察组治疗总有效率 96.00%高于对照组的 68.00%，差异有统计学意义（$P<0.05$）。治疗前，两组言语功能评分及孤独症行为量表（ABC）评分比较，组间差异无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后，观察组表达发育商（86.38±9.22）%及理解发育商（82.28±9.52）%均高于对照组，语言评分（11.38±1.88）分、感觉评分（10.24±1.26）分、交往评分（11.24±1.57）分、躯体运动评分（11.67±1.77）分、生活自理评分（9.45±1.42）分及 ABC 评分（61.03±11.83）分均低于对照组，组间差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论**　采用针刺联合穴位推拿治疗孤独症言语障碍患儿效果显著，可有效提升患儿言语功能，改善行为症状。

关键词： 孤独症言语障碍；针刺；穴位推拿；言语功能；行为症状

中图分类号：R749.94　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2096-7950(2024)09(b)-0044-04

Effect of Acupuncture Combined with Acupoint Massage on Speech Function and Behavioral Symptoms in Children with Autism Speech Disorders

LI Zhongcai

(Department of Children´s Rehabilitation, Tancheng County Maternal and Child Health and Family Planning Service Center, Linyi 276100, China)

Abstract: Objective　To explore the effect of acupuncture combined with acupoint massage on speech function and behavioral symptoms in children with autism speech disorders. **Methods**　Fifty children with autism speech disorders admitted to our hospital from October 2022 to May 2023 were selected as the research objects and divided into a control group and an observation group using a random number table method, with 25 cases in each group. The control group received routine training, while the observation group received acupuncture combined with acupoint massage on this basis. Compare the clinical efficacy, speech function and behavioral symptoms between two groups. **Results**　The total effective rate of the observation group was 96.00%, which was higher than 68.00% of the control group, and the difference was statistically significant($P<0.05$). Before treatment, there were no statistically significant differences in the speech function score and Autism Behavior Checklist (ABC) score between the two groups($P>0.05$); after treatment, the expression development quotient (86.38±9.22)% and understanding development quotient (82.28±9.52)% of the observation group were higher than those of the control group, while the language score (11.38±1.88) points, sensory score (10.24±1.26) points, social score (11.24±1.57) points, physical movement score (11.67±1.77) points, self-care score (9.45±1.42) points, and ABC score (61.03±11.83) points were lower than those of the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). **Conclusion**　Acupuncture combined with acupoint massage is effective in treating children with speech disorders in autism, which can help improve their speech function and behavioral symptoms.

Keywords: Autism speech disorder; Acupuncture; Acupoint massage; Speech function; Behavioral symptoms

作者简介：李重才（1984-），男，山东临沂人，本科，主治医师，研究方向：儿童孤独症、儿童脑瘫中医康复治疗。

中国知网　https://www.cnki.net

孤独症属于精神心理科常见疾病，言语障碍是其常见症状，患者会出现语言使用错误、无法表达正确意思、找词困难等多种表现，严重者甚至完全不能说话，对其日常生活及生活质量造成严重影响[1]。目前，孤独症言语障碍的发病机制尚未明确，西医尚无特效药治疗，采用语言训练可有效改善患儿的沟通及社交能力，但整体效果不佳[2]。在中医学中，孤独症属“五迟”“脏燥”范畴，主要是由于先天胎禀不足、肝肾亏损、后天失养、脑髓空虚所致，采用针刺治疗及穴位推拿刺激相关穴位，可有效疏通经络、平衡阴阳，改善患儿言语功能[3]。基于此，本研究选取 2022 年 10 月—2023 年 5 月本院收治的 50 例孤独症言语障碍患儿为对象，进行随机分组对照，探究针刺治疗联合穴位推拿对患儿的影响。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院收治的 50 例孤独症言语障碍患儿为研究对象，按照随机数字表法将其分为对照组和观察组，各 25 例。对照组中男 13 例，女 12 例；年龄 3~8 岁，平均年龄(5.58±1.20)岁；病程 10~36 个月，平均病程(23.29±6.34)个月。观察组中男 12 例，女 13 例；年龄 3~8 岁，平均年龄(5.52±1.21)岁；病程 10~36 个月，平均病程(23.67±6.15)个月。两组一般资料比较，差异无统计学意义(P>0.05)，具有可比性。本研究经院医学伦理委员会审批通过，患儿家属对本研究内容知情同意。纳入标准：符合孤独症言语障碍的中西医相关临床诊断标准，主要症状为语言迟钝、智力低下、精神呆滞、四肢松弛、纳食欠佳、大便多秘结、舌淡苔少、脉细[4-5]。排除标准：伴有心、肝等器官功能不全；于研究前接受过其他相关治疗；伴有恶性肿瘤或先天性遗传代谢疾病；既往存在颅脑外伤史；对针刺及推拿不耐受。

1.2 方法

对照组采用常规训练。由专业康复治疗师对患儿进行语言训练，先教患儿飞机声、枪声、猫叫声等患儿喜爱的或平常易听到的声音，然后过渡到爸爸、妈妈、姐姐等人称上，当患儿发出相应声音时，应及时给予其奖励。30 min/次，1 次/d，5 d/周，3 个月为 1 个疗程，共治疗 3 个疗程。

观察组采用针刺联合穴位推拿。(1)针刺：选取神庭、百会、印堂、四神聪、通里、内关、廉泉(右)、廉泉(左)、风府、合谷、哑门。嘱患儿取俯卧位，对患儿皮肤进行常规消毒后，选用 1 寸的毫针直刺，留针 45 min，1次/d。(2)穴位推拿：嘱患儿取仰卧位或坐卧位，选取人中、颊车、下关、承浆、地仓、井穴(少商、商阳、隐白、厉兑)、风池、风府、廉泉、通里穴位，使用一指禅推法对患儿上述穴位进行推拿治疗，30 min/次，1 次/d，5 d/周，3 个月为 1 个疗程，共治疗 3 个疗程。

1.3 观察指标

(1)临床疗效。显效：患儿孤独症行为量表(ABC)评分降低 5~10 分。有效：患儿 ABC 评分降低 3~4 分。无效：患儿 ABC 评分降低<3 分。治疗总有效率=(显效+有效)/总例数×100%[6]。(2)言语功能。于治疗前后，采用 S-S 语言发育迟缓检查表评估，包括表达能力、理解能力，表达能力及理解能力可参考发育年龄(DA)折算为发育商(DQ)，DQ=DA/实际年龄(CA)×100%[7]。DQ 等于 100%，表明患儿发育年龄与实际年龄相符，发育正常；DQ 大于 100%，表明患儿发育年龄超过实际年龄，发育超前；DQ 小于 100%，表明患儿发育年龄低于实际年龄，发育滞后。(3)行为症状。于治疗前后，采用 ABC 评价，由患儿家属辅助完成，共 5 个维度，57 个项目，总分 0~158 分，临界值为 67 分，评分越高表示患儿孤独症行为症状越严重。

1.4 统计方法

采用 SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析。计数资料用[n(%)]表示，组间比较采用 χ^2 检验；计量资料以($\bar{x}\pm s$)表示，组间比较采用独立样本 t 检验，组内比较采用配对样本 t 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组临床疗效比较

观察组治疗总有效率高于对照组，差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

表 1 两组孤独症言语障碍患儿临床疗效比较[n(%)]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
观察组	25	11(44.00)	13(52.00)	1(4.00)	24(96.00)
对照组	25	7(28.00)	10(40.00)	8(32.00)	17(68.00)
χ^2 值					4.878
P 值					0.027

2.2 两组言语功能比较

治疗前，两组表达发育商、理解发育商比较，组间差异无统计学意义(P>0.05)；治疗后，观察组表达发

中国知网 https://www.cnki.net

育商及理解发育商均较对照组高，组间差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 2。

表 2　两组孤独症言语障碍患儿言语功能比较[（$\bar{x}\pm s$），%]

组别	表达发育商		理解发育商	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组（n=25）	49.82±9.81	86.38±9.22	57.23±8.91	82.28±9.52
对照组（n=25）	49.83±10.25	68.47±7.75	54.91±7.72	76.38±8.20
t 值	0.004	7.435	0.984	2.348
P 值	0.997	0.000	0.330	0.023

2.3 两组行为症状评分比较

治疗前，两组 ABC 评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后，两组语言、感觉、交往、躯体运动、生活自理及 ABC 评分均较治疗前降低，且观察组均低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 3。

3　讨　论

孤独症是一组以社会交往障碍、言语和非语言交流障碍、刻板行为、狭隘兴趣为主要特征的神经发育障碍性疾病，以往称广泛性发育障碍。临床认为其为遗传与环境因素共同作用，与胎儿期病毒感染、免疫系统异常等因素有关。目前本病发病率显著上升，西医尚无根治方法，多采用康复训练以针对性改善患儿的语言与社交能力，但获益缓慢且时间较长，患儿依从性较差，效果欠佳[8]。

中医学认为，孤独症属“心神病变”“呆病”“语迟”“无慧”等范畴，其病因主要是先天禀赋不足，以致机体脏腑功能失调，阴阳失衡，脑髓空虚，且脾为后天之本，脾胃失养可引起肾精失养，导致患儿出现语言倒退等表现，治疗时应以开窍醒神、平衡阴阳、疏通经络、调节心肝肾等为基本原则。本研究结果显示，观察组治疗总有效率较对照组高，治疗后观察组表达发育商及理解发育商较对照组高，行为症状各项评分均较对照组低（$P<0.05$），提示对孤独症言语障碍患儿采用针刺联合穴位推拿治疗的效果显著，可提升患儿的言语功能，改善行为症状。分析其主要原因为，针刺及穴位推拿是常见的中医疗法，以脏腑经络理论为基础，通过对患儿的神庭、百会、印堂、四神聪等头部相应穴位进行针刺，可有助于刺激大脑皮质相关区域，恢复前额叶功能，调控神经递质释放，并增加大脑皮层对应部位血液灌注，改善患儿脑部缺氧、缺血状态，修复受损的神经组织，从而有利于增强脑细胞代谢功能，恢复脑环路，提升患儿语言能力，改善行为症状[9]。针刺治疗选取神庭、百会、四神聪、印堂、内关、廉泉等穴位，穴位推拿选取人中、承浆穴、颊车、下关、地仓、井穴（少商、商阳、隐白、厉兑）、风池、风府、廉泉等穴位，其中神庭为督脉穴，主治与神志相关病症；百会及四神聪可开窍醒神、调神定志、健脑益髓、安神醒脑；印堂可醒神开窍解语；廉泉可利窍通关、清火除湿；人中可解痉止痛、醒神开窍；承浆可开窍醒神、清热解毒、生津敛液；下关可消肿止痛、聪耳清窍、通经活络、疏风清热；地仓可祛风止痛、安神利窍、舒经活络；井穴（少商、商阳、隐白、厉兑）可疏通经络、宣导阴阳；风池可解表散寒、通利官窍、醒脑安神、发汗解表，此般诸穴配合，共奏平衡阴阳、疏通经络、生津清火、调脑心神、益髓健脑、定志安神、开窍醒脑之效[10]。因此，本研究将针刺治疗与穴位推拿联合使用，可促使其发挥协同作用，共同改善患儿的言语功能及行为症状。

综上所述，采用针刺联合穴位推拿治疗孤独症言语障碍患儿的效果显著，可有效提升患儿的言语功能，改善行为症状。

表 3　两组孤独症言语障碍患儿 ABC 评分比较[（$\bar{x}\pm s$），分]

组别	语言		感觉		交往	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组（n=25）	18.63±3.73	11.38±1.88#	13.48±1.62	10.24±1.26#	19.21±2.11	11.24±1.57#
对照组（n=25）	18.71±3.87	13.75±2.46#	13.41±1.58	11.58±1.43#	18.88±2.17	13.25±1.88#
t 值	0.074	3.827	0.155	3.515	0.545	4.103
P 值	0.941	0.000	0.878	0.001	0.588	0.000

组别	躯体运动		生活自理		总分	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组（n=25）	14.77±2.24	11.67±1.77#	13.81±1.73	9.45±1.42#	83.73±13.52	61.03±11.83#
对照组（n=25）	14.89±2.34	13.42±2.08#	13.93±1.82	11.36±1.64#	81.55±11.96	68.15±12.73#
t 值	0.185	3.204	0.239	6.707	0.604	2.049
P 值	0.854	0.002	0.812	0.000	0.549	0.046

注：与同组治疗前比较，#$P<0.05$。

（下转第 50 页）

中国知网　https://www.cnki.net

通过药效渗透作用促进局部血液循环，扩张毛细血管，增加组织细胞的营养供给，促进面部神经的再生与修复。同时，中药穴位贴敷还具有消肿止痛、祛湿化痰的作用，可以减轻面部疼痛，恢复面部肌肉的正常张力，有利于面部功能的恢复和改善。本研究结果显示，治疗 2 个疗程后，观察组口眼歪斜、眼裂增大、患侧额纹消失、眼睑难以闭合评分均较对照组低，Sunnybrook 评分较对照组高，面动脉的 Vs、Vd 均较对照组快，RI 水平较对照组低，FDI 评分较对照组高（$P<0.05$）。分析原因为，温针灸结合了针刺和艾灸的特点，通过同时刺激穴位和施加热能来调理人体的气血运行，选取的主要穴位如丝竹空、下关、攒竹等，针刺这些穴位可以刺激相关的经络，加速局部的气血循环，有助于恢复面部神经功能；配合风池、列缺、合谷等辅助穴位，可以更全面地调理患者的气血[9]。中药穴位贴敷对风寒袭络型周围性面瘫患者的面神经功能具有改善作用，白芥子有辛温散寒的作用，可以温通经络、祛风散寒，适用于治疗风寒引起的面部肌肉麻痹或面瘫；桂枝有温阳散寒的作用，可以促进气血运行，温通经络，帮助恢复受损的神经功能；当归具有活血调经的功效，能够改善微循环，促进面部血液循环；僵蚕可舒筋活络、通经活血，可缓解面部肌肉痉挛、萎缩等症状；诸药共奏温经散寒、活血化瘀、通络止痛的功效，能够有效缓解风寒袭络型周围性面瘫患者的症状[10]。

综上所述，温针灸联合中药穴位贴敷干预对风寒袭络型周围性面瘫患者面神经功能的恢复具有促进作用，同时能改善面部血液循环，减轻症状和面瘫程度。

参 考 文 献

[1] 王岚萱,吴若辉,贺小卉,等.牵正散合桂枝加葛根汤加减、温针灸联合康复训练治疗顽固性周围性面瘫临床研究[J].陕西中医,2020,41(9):1262-1265.

[2] 张加英,徐炳国,戴丽娟,等.牵正穴温针灸治疗周围性面瘫的临床观察[J].中国中医急症,2020,29(4):678-680.

[3] 黄晶,王宝爱,马力.中药湿热敷联合肌电生物反馈疗法治疗气虚血瘀型面瘫的临床效果及对面神经传导功能的影响[J].新疆医科大学学报,2023,46(4):527-532.

[4] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会神经肌肉病学组,中华医学会神经病学分会肌电图与临床神经电生理学组.中国特发性面神经麻痹诊治指南[J].中华神经科杂志,2016(2):84-86.

[5] 高树中,杨骏,针灸治疗学[M].10 版.北京:中国中医药出版社,2016:147-148.

[6] 刘祎思,贺思圣,李冬梅,等.中药熏蒸联合针刺对中风后面瘫患者免疫及面神经功能的影响[J].现代中西医结合杂志,2020,29(30):3336-3339,3349.

[7] 严娅岚,贾海滨,李培玉,等.基于面部神经功能及中医症状评分探究温针灸对周围性面瘫患者预后的影响[J].天津中医药,2023,40(8):1023-1028

[8] 周强,刘柯里,董双节.温针灸翳风穴联合中药贴敷对面瘫患者HBGS、FDI 评分及社会功能的影响[J].西部中医药,2023,36(9):120-123.

[9] 贝秉袁,钟伟泉,老锦雄.面部电针联合双下肢阴、阳经温针灸治疗周围性面瘫临床研究[J].中国中医急症,2020,29(3):453-455,484.

[10] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则:试行[M].中国医药科技出版社,2002.

（收稿日期：2024-04-15）
编辑：黄巍

（上接第 46 页）

参 考 文 献

[1] 党伟利,李伟,马丙祥.针刺内关穴干预孤独症谱系障碍言语功能的临床研究[J].中国康复医学杂志,2022,37(7):961-963.

[2] 杜翔,陈嘉,吴兆芳,等.鬼穴结合辨证分型针刺治疗对孤独症谱系障碍儿童核心症状的影响[J].针刺研究,2021,46(8):695-699.

[3] 冯祥,葛君芸,张宇星,等.基于“五脏相通”理论探讨推拿干预孤独症谱系障碍的思路与方法[J].中华中医药杂志,2021,36(11):6485-6489.

[4] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statist icalManual of Mental Disorders[M]. 5 ed.New York:NewSchool Library,2013.

[5] 汪受传.中医儿科学[M].2 版.北京:人民卫生出版社,2011:174-179.

[6] HAEM E, DOOSTFATEMEH M, FIROUZABADI N, et al. A longitudinal item response model for Aberrant Behavior Checklist (ABC) data from children with autism[J]. J Pharmacokinet Pharmacodyn,2020,47(3):241-253.

[7] FOSTER N E V, OUIMET T, TRYFON A, et al. Effects of age andattention on aulitory global: local processing in chil-dren with autism spectnum disorder[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders,2016,46(4):1415-l428.

[8] 崔方方.听力障碍合并孤独症倾向儿童听觉语言康复训练个案分析[J].中国听力语言康复科学杂志,2021,19(1):75-78.

[9] 王静,刘芸,黄浩宇,等.针刺对孤独症谱系障碍患儿临床表现及胃肠症状的影响[J].中国针灸,2022,42(12):1373-1376.

[10] 郭凯,李建军,张倩,等.舌三针结合穴位按摩改善孤独症谱系障碍患儿言语障碍临床观察[J].中国医药导刊,2022,24(11):1084-1088.

（收稿日期：2024-05-09）
编辑：齐霁

中国知网 https://www.cnki.net